

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS

Maria Cristina Teresa da Silva

IDADE: 54 PESO: 123 ALTURA: 165 PROFISSÃO: ADM -

SINTOMAS: Refluxo gástrico / agitada

QUEIXAS: cansaço

MEDICAMENTOS: Quetiapina / sertralina / Atenolol (12,5) / Nebivolol 5mg
HAS / Pós-Bariátrica (há 23 anos) / Cecendo.

MÉDICO: Drª Mariaah (160,50 kg) / Gabriela Martins (cardio)

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO: não está fazendo. (2x semana hidroq.)

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: S 19h

HORA QUE DORME: 21:30 HORA QUE ACORDA: 5h

COCHILO () SIM ☒ NÃO DORME ACOMPANHADO () SIM ☒ NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA ☒ NÃO

FUMO () SIM () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 1x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: globosa CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: nega MALLAMPATI: IV IAH: 57. SPO2: 76%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Atelectasia / Bronquite

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: Provável

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDOCRINA (S) CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS

28/05/24 Avaliação.
CPAP pressão automática

04/06/24 - P=10.5 cmH₂O ajuste
IAH= 0.4 e/ev
m. de uso: 6h.
mantém bem adapt. Jua

25/06/24 P= 10.2 cmH₂O
IAH= 0.2 e/ev
m. de uso: 6h 14'
fuga= 3.3 lpm. Jua

22/07/24 P= 10.2 cmH₂O
IAH= 0.2 e/ev
m. de uso: 7h 05' Jua

10/09/24 P= 10.2 cmH₂O
IAH= 0.3 e/ev
m. de uso: 5h 13' Jua.
Retirou Zopiclona e parou p/ Prisma.
Refluxo gástrico.

15/10/24 P= 10.2 cmH₂O
IAH= 0.1 e/ev
m. de uso: 7h 6'
fuga= 0.8 lpm
Bem adaptavel, s/ queixas.
Tomando Prisma 5mg. Jua

10/12 Trocou o remédio está esquecendo de colocar.

24 P: 10.2 cmHg O
IAH = 0.1 efv
m. de uso: 5h42'

lua cláudia

Nome: MARIA CRISTINA TEREZA DA SILVA

Data de Nascimento: 20-1-1970

IMC: 45,18

Sexo: Feminino

Data do exame: 24-02-2024

Peso: 123 kg

Altura: 1,65 m

Médico: DRA. GABRIELA MARTINS

NOVAES DE ASSIS PEDRUCCI

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 24-02-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 438,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 13,5 e 102,0 minutos. O tempo total de sono foi de 405,5 min, eficiência de 92,5% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,7%; estágio N2: 70,4%; estágio N3: 10,1%; sono REM: 17,8%. O índice de despertares foi de 37,8/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 57,0/hora, sendo 20 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 343 hipopnéias. A SpO2 média foi de 88% e a mínima de 76%, permanecendo 57,4% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 71 - 94 bpm e NREM de 67 - 103 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (0), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono preservada;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 57,0/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (mín. SaO2=76%);
5. latências para o sono normais;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

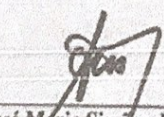
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Receituário



SAO JOSE DOS CAMPOS, 26 de março de 2024.

Sra. Maria Cristina Tereza da Silva

Prescrição:

Solcito

CPAP auto
rampa auto
titulação domiciliar

sugerido máscara nasal

[Handwritten signature]
Dra. Maria Prata S. F. Taube
Pneumologista
CRM-SP-134230 RQE-45087

Marian Prata Soldi Passos Taube (CRM 134230)